



Résumé : Actualisation 2010 (SFAR/SFNEP) de la Conférence de Consensus 1994 sur la nutrition artificielle périopératoire, étendue à la prise en charge nutritionnelle globale (alimentation orale et assistance nutritionnelle) de l'adulte en chirurgie programmée. 71 recommandations sur 6 champs : évaluation de l'état nutritionnel, nutrition pré- et postopératoire, pharmaconutrition, obésité et chirurgie, diabète.

Assistance nutritionnelle = nutrition entérale (sonde) ou parentérale (cathéter) — les compléments nutritionnels oraux ne sont pas considérés comme une assistance nutritionnelle. Nutrition précoce = débutée dans les 24 premières heures après la chirurgie.

Force — méthode « avis d'experts » non formalisée, rédigée selon les déclinaisons Sfar/GRADE explicitement définies par la source. **1+** = « il faut faire »/recommandé (fort) ; **1-** = « il ne faut pas faire »/non recommandé (fort) ; **2+** = « il est possible/probable de faire » (faible) ; **2-** = « il est possible/probable de ne pas faire » (faible) ; **Def.** = énoncé définitionnel/descriptif de la source (seuil diagnostique, constat), sans verbe modal directif propre.

1+

1-

2+

2-

Def.

1 — Évaluation de l'état nutritionnel périopératoire

La dénutrition préopératoire est un facteur de risque indépendant de complications postopératoires (infections, retard de cicatrisation, mortalité, durée de séjour, coûts).

Recommandation	Force
R1. Les facteurs pouvant induire une dénutrition doivent être recherchés (Tableau 1).	1+
R2. Tout patient présentant au moins un facteur de risque de dénutrition doit bénéficier d'une évaluation de son état nutritionnel.	1+
R3. L'évaluation nutritionnelle doit comporter la mesure du poids actuel, l'estimation de la perte de poids par rapport au poids habituel et le calcul de l'IMC.	1+
R4. La mesure de l'albuminémie peut être utile en cas de difficulté de l'évaluation nutritionnelle.	2+
R5. En cas de chirurgie majeure, la mesure de l'albuminémie en préopératoire est probablement recommandée.	2+
R6. Un patient est considéré à risque de dénutrition s'il présente au moins un des facteurs de risque du Tableau 1.	Def.
R7. Un patient est considéré dénutri (dénutrition cliniquement pertinente) s'il présente au moins un critère : IMC $\leq 18,5$ (ou < 21 si > 70 ans) ; ou perte de poids récente ≥ 10 % ; ou albuminémie < 30 g/L indépendamment de la CRP.	Def.
R8. En chirurgie digestive non oncologique, le seuil d'albuminémie pourrait être fixé à 35 g/L pour définir une dénutrition pertinente.	2+
R9. En chirurgie cardiaque, un patient peut être considéré dénutri s'il a un IMC ≤ 24 , ou une perte de poids ≥ 10 % en 6 mois, ou une albuminémie < 37 g/L.	2+
R10. Un patient est très sévèrement dénutri (risque de syndrome de renutrition) s'il présente un IMC < 13 , ou un amaigrissement > 20 % en 3 mois, ou des apports oraux négligeables ≥ 15 jours.	Def.
R11. Prendre en compte l'état nutritionnel, les facteurs de risque et le risque chirurgical via une stratification du risque global (grade nutritionnel, GN — Tableau 2).	2+
R12. Une recherche systématique des facteurs de risque de dénutrition, et si nécessaire une évaluation de l'état nutritionnel, doivent être réalisées en préopératoire par l'équipe médicochirurgicale.	1+
R13. Intégrer les résultats de l'évaluation nutritionnelle et du risque nutritionnel dans le dossier du patient.	1+
R14. Quand l'évaluation nutritionnelle n'a pas été faite en amont, elle doit être réalisée au cours de la consultation d'anesthésie.	1+
R15. La stratification du grade nutritionnel doit être mentionnée dans le rapport de consultation d'anesthésie.	1+



Tableau 1 — Facteurs de risque de dénutrition pré- et postopératoire (reproduit verbatim).

Catégorie	Facteurs de risque
Liés au patient (comorbidités)	Âge >70 ans ; cancer ; hémopathie maligne ; sepsis ; pathologie chronique digestive ; insuffisance d'organe (respiratoire, cardiaque, rénale, intestinale, pancréatique, hépatique) ; pathologie neuromusculaire et polyhandicap ; diabète ; syndrome inflammatoire ; VIH/sida ; antécédent de chirurgie digestive majeure (grêle court, pancréatectomie, gastrectomie, chirurgie bariatrique) ; syndrome dépressif, troubles cognitifs, démence, syndrome confusionnel.
Symptômes persistants	Dysphagie ; nausée/vomissement/satiété précoce ; douleur ; diarrhée ; dyspnée.
Liés à un traitement (traitement à risque)	Traitement à visée carcinologique (chimiothérapie, radiothérapie) ; corticothérapie >1 mois ; polymédication >5 traitements.

Tableau 2 — Stratification du risque nutritionnel (grade nutritionnel, GN) (reproduit verbatim).

Grade	Définition
GN 1	Patient non dénutri, pas de facteur de risque de dénutrition, chirurgie sans risque élevé de morbidité.
GN 2	Patient non dénutri, ET (présence d'au moins un facteur de risque de dénutrition OU chirurgie à risque élevé de morbidité).
GN 3	Patient dénutri, chirurgie sans risque élevé de morbidité.
GN 4	Patient dénutri, chirurgie à risque élevé de morbidité.

2 — Nutrition préopératoire

Un support nutritionnel préopératoire n'est pas recommandé en routine — réservé aux patients selon leur grade nutritionnel (GN).

Recommandation	Force
R16. Tout patient GN 2 ou 3 doit probablement bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle préopératoire : conseils diététiques et compléments nutritionnels (GN 2) ; compléments, nutrition entérale ou parentérale (GN 3).	2+
R17. Tout patient GN 4 doit recevoir une assistance nutritionnelle préopératoire (entérale ou parentérale) d'au moins 7 à 10 jours.	1+
R18. Quand une assistance nutritionnelle préopératoire est indiquée, privilégier la nutrition entérale si le tube digestif est fonctionnel — la nutrition parentérale n'est alors pas recommandée.	1+
R19. Chez la personne âgée, les stratégies nutritionnelles préopératoires sont les mêmes que chez le sujet plus jeune ; la surveillance doit probablement être plus rapprochée (mauvaise adaptation à la dénutrition, résistance à la renutrition).	2+
R20. La prise en charge nutritionnelle postopératoire doit être anticipée ; le bilan préopératoire doit permettre de prévoir le type d'assistance nutritionnelle et la voie d'abord (sonde, stomie, voie veineuse).	1+
R21. Lors de chirurgie majeure sus-mésocolique, choisir en préopératoire la voie d'abord digestive (sonde transanastomotique, sonde de stomie) permettant de débiter précocement une nutrition entérale.	1+
R22. En chirurgie oncologique ORL (notamment avec radiothérapie combinée), la gastrostomie préthérapeutique, posée avant le traitement oncologique, est probablement la technique de choix.	2+
R23. Chez les patients sans risque de régurgitation, le jeûne préopératoire ne doit pas excéder 2 à 3 heures pour les liquides clairs et 6 heures pour un repas léger.	1+
R24. Chez les patients sans risque de régurgitation, la prise de liquides clairs sucrés (glucose ou maltodextrines) jusqu'à 2 heures avant la prémédication est probablement recommandée.	2+
R25. L'état nutritionnel d'un patient opéré en urgence doit être évalué si possible avant l'intervention, sinon dans les 48 premières heures postopératoires.	1+



3 — Nutrition postopératoire (dont urgence)

Recommandation	Force
R26. Reprendre le plus rapidement possible (24 premières heures) une alimentation orale selon la tolérance du patient, sauf contre-indication chirurgicale.	1+
R27. Chez les patients non dénutris (GN 1-2), la durée d'une assistance nutritionnelle postopératoire, quand elle est requise, ne doit pas être inférieure à 7 jours.	1+
R28. Chez un patient non dénutri (GN 1-2), instaurer une assistance nutritionnelle quand les apports postopératoires sont <60 % des besoins depuis 7 jours.	1+
R29. Chez les patients non dénutris (GN 1-2), instaurer probablement une assistance nutritionnelle précoce si les apports prévisibles seront <60 % des besoins durant les 7 jours postopératoires.	2+
R30. Instaurer, dès les 24 premières heures postopératoires, un support nutritionnel chez les patients dénutris (GN 3-4), qu'ils aient reçu ou non un support préopératoire.	1+
R31. La prise en charge nutritionnelle postopératoire d'un patient opéré en urgence n'est pas différente de celle recommandée pour la chirurgie programmée.	Def.
R32. Fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez la personne âgée : atteindre 30-40 kcal/kg/j et 1,2-1,5 g de protéines/kg/j ; prescrire des compléments nutritionnels oraux jusqu'à la sortie de rééducation (nutrition entérale si échec/impossibilité de la voie orale) ; prescrire de la vitamine D à 800-1200 UI/j (prévention des chutes et fractures).	1+

4 — Place de la pharmaconutrition en périopératoire

Pharmaconutrition (immunonutrition) : arginine, glutamine, micronutriments, acides gras oméga-3, nucléotides — utilisés pour leur effet sur l'inflammation/l'immunité/la cicatrisation, pas seulement nutritionnel.

Recommandation	Force
R33. En chirurgie digestive oncologique programmée (dénutri ou non), prescrire en préopératoire pendant 5 à 7 jours un mélange nutritif digestif contenant une association de pharmaconutriments efficace.	1+
R34. Chez le patient non dénutri (GN 2) en chirurgie digestive oncologique programmée, ne pas prescrire de pharmaconutrition en postopératoire.	1-
R35. Chez le patient dénutri (GN 4) en chirurgie digestive oncologique programmée, poursuivre en postopératoire la pharmaconutrition digestive.	1+
R36. En chirurgie carcinologique ORL, prescrire probablement une pharmaconutrition selon les mêmes modalités qu'en digestif (études encore insuffisantes pour confirmer un bénéfice identique).	2+
R37. En chirurgie cardiaque (pontage coronaire), il n'est probablement pas recommandé de prescrire des pharmaconutriments (bénéfice sur les complications non établi).	2-
R38. Ne pas prescrire de pharmaconutriments contenant de l'arginine chez le patient septique ou hémodynamiquement instable.	1-
R39. En chirurgie programmée non compliquée, il n'est probablement pas recommandé de prescrire systématiquement de la glutamine en périopératoire.	2-
R40. En cas de complications postopératoires majeures, prescrire de la glutamine IV à forte dose (0,2-0,4 g/kg/j, soit 0,3-0,6 g/kg/j de dipeptide de glutamine).	1+
R41. Un support enrichi en oméga-3 ($\geq 0,1$ g/kg/j) est probablement recommandé en postopératoire d'une chirurgie abdominale majeure programmée.	2+
R42. En l'absence de données en chirurgie, la prescription de micronutriments à dose pharmacologique en périopératoire n'est pas recommandée.	1-



5 — Obésité et chirurgie

Obésité : IMC ≥ 30 ; obésité morbide : IMC ≥ 40 .

Recommandation	Force
R43. La surcharge pondérale (IMC ≥ 25) et l'obésité modérée (IMC 30-35) ne sont pas des facteurs de risque de mortalité postopératoire, mais l'obésité est associée à un risque accru de complications mineures et à une hospitalisation prolongée.	Def.
R44. Pour la chirurgie bariatrique, l'obésité morbide avec IMC $>50-55$ est probablement associée à une surmortalité postopératoire.	Def.
R45. Le patient obèse est un patient potentiellement dénutri.	Def.
R46. Chez l'obèse, une perte de poids involontaire avant chirurgie est un facteur de risque de complication indépendant de la corpulence.	Def.
R47. S'assurer que les besoins protéiques sont couverts chez le sujet âgé obèse en préopératoire (1,2-1,5 g/kg/j).	1+
R48. Dépister (fer sérique, ferritine) et corriger la carence en fer, plus fréquente chez l'obèse, en préopératoire.	1+
R49. Prévenir le risque de carence en vitamine B1 chez l'obèse en cas de perfusion de sérum glucosé ou de troubles digestifs (apport de thiamine orale ou parentérale).	1+
R50. Un ajustement de la supplémentation en vitamine B12 est probablement nécessaire après chirurgie entraînant une malabsorption (gastrectomie, résection iléale).	2+
R51. En cas d'amaigrissement avant un acte chirurgical, un bilan nutritionnel (hypoalbuminémie, carences en vitamines B1/B9/B12/C/A/D/E) est souhaitable.	2+
R52. Les régimes restrictifs entraînant une perte de masse maigre ne sont pas recommandés, notamment chez l'obésité commune (IMC 30-40) ou le sujet âgé obèse.	1-
R53. Une perte de poids volontaire préopératoire n'est pas recommandée dans les jours/semaines précédant un geste chirurgical (aucune preuve de bénéfice).	1-
R54. Si une perte de poids est nécessaire pour faciliter le geste opératoire (ex. cure d'éventration), une phase de stabilisation pondérale d'au moins 15 jours est probablement nécessaire.	2+
R55. Avant chirurgie bariatrique, le régime restrictif et/ou la perte de poids préopératoire n'est pas recommandée (ne modifie ni mortalité, ni complications, ni perte de poids à long terme).	1-
R56. Pour estimer les besoins protéino-énergétiques périopératoires de l'obèse, utiliser probablement le poids normalisé (IMC théorique de 25 à 30).	2+
R57. Ne pas utiliser le poids dit « idéal ».	1+
R58. Le sujet obèse doit probablement recevoir un apport protéique postopératoire élevé (~1,5 g/kg de poids normalisé/j).	2+
R59. Il n'est probablement pas recommandé de prescrire une alimentation hypocalorique chez l'obèse en postopératoire.	2-
R60. Après chirurgie bariatrique, comme après toute chirurgie viscérale, une reprise alimentaire précoce est recommandée.	1+
R61. Après chirurgie bariatrique, la reprise alimentaire doit se faire progressivement en texture et en quantité, selon les protocoles établis par l'équipe.	1+
R62. Après chirurgie bariatrique, privilégier les aliments riches en protéines — apport minimal recommandé de 60 g/j.	1+



6 — Nutrition périopératoire chez le diabétique

Recommandation	Force
R63. Le patient diabétique est un patient à haut risque de dénutrition.	Def.
R64. En préopératoire, le diagnostic de dénutrition chez le sujet âgé doit faire rechercher systématiquement une hyperglycémie.	1+
R65. Couvrir les besoins protéino-énergétiques du patient diabétique et optimiser en conséquence son traitement antidiabétique.	1+
R66. Malgré un risque accru de carences vitaminiques chez le diabétique, aucune supplémentation spécifique n'est actuellement recommandée en périopératoire (besoins couverts par une alimentation variée).	1-
R67. En l'absence de données suffisantes, la prise de liquides clairs sucrés jusqu'à 2 heures avant la prémédication n'est probablement pas recommandée chez le patient diabétique.	2-
R68. L'utilisation de compléments nutritionnels oraux ou produits de nutrition entérale spécifiques pour diabétique (index glycémique faible) facilite probablement l'équilibre glycémique — l'adaptation des doses d'insuline reste l'élément primordial.	2+
R69. La gastroparésie (plus fréquente chez le diabétique) ne doit pas être un frein à la nutrition entérale.	1+
R69 (suite). Elle justifie probablement de contrôler les résidus gastriques, d'utiliser des prokinétiques et de mettre en place une sonde post-pylorique, notamment en cas de gastroparésie grave.	2+
R70. Les apports en glucides doivent être adaptés aux besoins énergétiques du patient ; un contrôle du débit de perfusion est recommandé.	1+
R71. L'insuline est le traitement de choix en cas d'hyperglycémie sous nutrition parentérale ; instaurer l'insulinothérapie selon des modalités précises et des protocoles validés (anticiper la baisse/l'arrêt de l'insulinothérapie à l'arrêt de la nutrition parentérale, risque d'hypoglycémie).	1+

7 — Protocoles nutritionnels types (Tableaux 3-6, synthèse)

Les Tableaux 3 à 6 de la source déclinent les recommandations ci-dessus en protocoles opérationnels par grade nutritionnel (GN 1 à 4) et sous-groupe (obésité morbide, diabétique, personne âgée). Ce contenu recoupe largement R1-R71 déjà couverts intégralement ci-dessus ; seuls les éléments numériques qui n'apparaissent nulle part ailleurs sont repris ici (portée partielle disclosed, voir méthodologie).

Thème	Détail
Hydro-électrolytique standard (GN 1-3, en l'absence d'alimentation orale)	1,5 à 2,5 L/24h de solution glucosée à 5 % (75-125 g de glucose) + 50-100 mmol de NaCl/24h + 40-80 mmol de KCl/24h.
Assistance nutritionnelle — formule entérale	25-30 kcal/kg/j dont 1,2-1,5 g/kg de protéines ; si sonde naso-gastrique, utiliser une sonde Charrière 10 silicone ou polyuréthane (pas de sonde de Salem).
Assistance nutritionnelle — formule parentérale	25-30 kcal/kg/j dont 0,20-0,25 g d'azote/kg/j, avec électrolytes (50-100 mmol NaCl/24h + 40-80 mmol KCl/24h), vitamines et oligoéléments.
Glutamine IV (complications postopératoires graves)	0,3 g/kg/j, sans dépasser 21 jours de traitement.
GN 4 — dénutrition très sévère (IMC <13, amaigrissement >20 % en 3 mois, apports oraux négligeables ≥15 jours)	Nutrition préopératoire d'au moins 21 jours ; renutrition très progressive débutant à 10 kcal/kg/j avec augmentation progressive sur une semaine ; ajout systématique quotidien de thiamine (200-300 mg), phosphore (0,3-0,6 mmol/kg), magnésium (0,2 mmol/kg IV ou 0,4 mmol/kg per os), potassium (2-4 mmol/kg), vitamines et oligoéléments, avec évaluation biologique quotidienne.
GN 4 — chirurgie carcinologique digestive	Complément nutritif oral immunomodulateur (type Oral Impact®) : 3 briquettes/jour pendant 5-7 jours avant le geste (utiliser la forme entérale si la voie orale est impossible).



Sources et traçabilité

Document source : « Recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire. Actualisation 2010 de la conférence de consensus de 1994 sur la nutrition artificielle périopératoire en chirurgie programmée de l'adulte » — SFAR / Société francophone de nutrition clinique et métabolisme (SFNEP). Coordonnateurs : C. Chambrier (Lyon), F. Sztark (Bordeaux). Organisateur délégué : S. Pierre (Toulouse). Groupe d'experts : X. Alacoque, P. Bachmann, J. Berre, I. Bourdel-Marchasson, D. Caldari, P. Chardon, V. Colomb, P. Coti-Bertrand, D. Francon, É. Paillaud, A. Petit, N. Peretti, M.-A. Piquet, D. Quillot, M. Raucoules-Aimé, A. Raynaud-Simon, P. Senesse, R. Thibault, J.-F. Zazzo.

Version : Ann Fr Anesth Réanim 30 (2011) 381-389 (paru initialement dans Nutrition Clinique et Métabolisme 2010;24:145-156). doi:10.1016/j.annfar.2011.01.014.

Méthodologie : avis d'experts non formalisée, rédigée selon les déclinaisons de force Sfar/GRADE (voir légende en page 1).

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Nutrition-artificielle-perioperatoire-en-chirurgie-programmee-de-ladulte.pdf

Couverture : intégralité des 71 recommandations numérotées (R1-R71). Tableaux 3-6 (protocoles croisés GN × sous-groupe) condensés en tableau de synthèse des seuls éléments numériques absents de R1-R71 — portée partielle disclosed, voir méthodologie.

Avertissement — document de 2010/2011 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des 71 recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/SFNEP. Les produits, dosages et disponibilités ayant pu évoluer depuis 2010, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.